

NUEVOS FARMACOS AUTORIZADOS: FDA Y EMA

APROBACIONES DE FDA

Fármaco: NAVEPEGITIDE

1. Nombre Comercial: Yuviwel
2. Vía de administración: Subcutánea
3. Laboratorio:
4. Población Destinataria: Acondroplasia. Niños mayores de 2 años con la forma más común de enanismo.
5. Efecto en estudios: Al cabo de 52 semanas los niños tienen una talla 1,5 cm superior al placebo

Fármaco: ICOTROKINRA

1. Nombre Comercial: Icotyde
2. Mecanismo de acción: Bloqueo de IL-23
3. Vía de Administración: Oral un vez por día
4. Laboratorio: Johnson & Johnson / Janssen
5. Población Destinataria: Pacientes adultos y adolescentes (mayores de 12 años) con psoriasis en placa severa
6. Efecto en estudios: Cuatro estudios lo compararon contra placebo y en dos de ellos contra droga activa (deucravacitinib y ustekinumab), los estudios mostraron mayor eficacia contra placebo y contra comparadores activos

Fármaco: LINERIXIBAT

1. Nombre Comercial: Lynavoy
2. Mecanismo de acción: Inhibidor de IBAT que reduce la reabsorción de ácidos biliares
3. Forma Farmacéutica: Comprimido oral dos veces por día
4. Laboratorio: GSK
5. Población Destinataria: Pacientes con prurito severo por colangitis biliar primaria
6. Efecto en estudios: Rápida y sostenible reducción del prurito

Fármaco: RELACORILANT + NAB-PACLITAXEL

1. Mecanismo de acción: Antagonista del receptor de glucocorticoide + nab-paclitaxel
2. Nombre Comercial: Lifyorli

3. Forma Farmacéutica: IV
4. Laboratorio: Corcept
5. Población Destinataria: Pacientes con cáncer de ovario, trompas de Falopio o peritoneo refractarias a regímenes que incluyeron bevacizumab
6. Efecto en estudios: La sobrevida libre de enfermedad se extendió de 5,5 a 6,5 meses, mientras que la sobrevida global paso de 11,5 a 16 meses.

Fármaco: INSULINA ICODEC-ABAE

1. Mecanismo de acción: Insulina
2. Nombre Comercial: Awikli
3. Forma Farmacéutica: Inyeccion subcutánea SEMANAL de insulina basal
4. Laboratorio: Novo Nordisk
5. Población Destinataria: Pacientes con Diabetes II insulín dependiente
6. Efecto en estudios: Cuatro estudios contra diferentes comparadores: GLP-1, insulina glargina, insulina degludec mostro superioridad en la reducción de HbA1c a la semana 52, mientras que un estudio contra insulina basal diaria + rápida prandial mostro no inferioridad

APROBACIONES DE EMA:

Fármaco: FINERENONA

1. Mecanismo de acción: Bloqueo del receptor de mineralocorticoide
2. Nombre Comercial: Kerendia
3. Forma Farmacéutica: comprimidos
4. Laboratorio: Bayer
5. Población Destinataria: Pacientes Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección levemente deprimida o normal (>40%)
6. Efecto en estudios: Estudio publicado en: **N Engl J Med 2024;391:1475-1485** el resultado primario fue: Descompensación de IC (Hospitalización o consulta a urgencias) + Muerte de causa cardiovascular, y mostro que comparado con placebo en el grupo de finerenona hubo significativamente menos eventos: HR 0,84 (IC95% 0,74 a 0,95) p=0,007. El componente de fallecimiento no fue estadísticamente significativo: HR 0,93 /IC95%: 0,78 a 1,1) por lo que el beneficio principal fue la reducción de descompensaciones no fatales. Finerenona como se esperaba aumentó la incidencia de hiperkalemia y redujo la de hipocalemia.
7. FARMACO DISPONIBLE EN ARGENTINA: FIRIALTA (Bayer)

Fármaco: REMIBRUTINIB

1. Nombre Laboratorio: NOVARTIS
2. Nombre comercial: Rapsida®
3. Mecanismo de Acción: Bloqueo de BTK
4. Vía de administración: Oral dos dosis diarias
5. Fecha del anuncio de resultados: 29/4/2026
6. Fuente del anuncio: EMA
7. Tipo de enfermedad objetivo: Urticaria Crónica Espontanea
8. Población Destinataria: Pacientes con UCE
9. Efecto en estudios: Los estudios REMIX 1 y 2 mostraron una superioridad significativa contra placebo en prurito y los escores de actividad de urticaria.
10. Implicancia médico-económica: Novartis planea expandir su uso para otras condiciones como alergias alimentarias, hidradenitis supurativa y urticaria inducible.

Fármaco: PEMBROLIZUMAB + PACLITAXEL

1. Nombre Laboratorio: MSD
2. Vía de administración: Parenteral
3. Fecha del anuncio de resultados: 29-4-2026
4. Fuente del anuncio: EMA
5. Tipo de enfermedad objetivo: Cancer de Ovario, trompas de Falopio y peritoneo primario.
6. Población Destinataria: Paciente con Cancer de Ovario, trompas de Falopio y peritoneo primario recurrentes o refractarios a QTX basada en platino. Puede asociarse o no a bevacizumab
7. Efecto en estudios: Significativo incremento de la sobrevida libre de enfermedad
8. Implicancia médico-económica: Primer inmunoterapia aprobada en estos tipos de neoplasia.

REUNIONES DEL COMITÉ DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO (CHMP) DE LA EMA. Aspectos Destacados

24-04-26

Cinco nuevos medicamentos recomendados para su aprobación

El Comité de Medicamentos para Uso Humano (CHMP) de la EMA recomendó la aprobación de cinco medicamentos en su reunión de abril de 2026.

El comité recomendó otorgar la autorización de comercialización para **Cenrifki (tolebrutinib)**, para el tratamiento de la esclerosis múltiple progresiva secundaria no recurrente, una enfermedad del cerebro y la médula espinal en la que la inflamación destruye la capa protectora que rodea los nervios y los propios nervios.

El CHMP recomendó conceder la autorización de comercialización para el medicamento de terapia génica **Itvisma (onasemnogene abeparvovec)**, para el tratamiento de la atrofia muscular espinal, una enfermedad hereditaria rara y grave que causa debilidad y desgaste muscular.

El CHMP emitió una opinión favorable sobre **Redemplo (plozasirán)** para el tratamiento de adultos con síndrome de quilomicronemia familiar, una enfermedad hereditaria rara que impide al organismo metabolizar los lípidos (grasas). Este medicamento ofrece una nueva opción de tratamiento para pacientes con una gran necesidad médica no cubierta. Consulte más detalles en el comunicado de prensa que aparece a continuación.

El comité recomendó otorgar la autorización de comercialización para **Rexatilux (ranibizumab)**, un medicamento biosimilar para el tratamiento de varias enfermedades oculares que causan discapacidad visual.

Un medicamento genérico, **Palbociclib Viatris (palbociclib)**, recibió una opinión positiva para el tratamiento del cáncer de mama.

Recomendaciones sobre la ampliación de la indicación terapéutica de nueve medicamentos.

El comité recomendó la ampliación de la indicación de nueve medicamentos que ya están autorizados en la Unión Europea (UE): Agamree , Aquipta , Crysvita , Comirnaty , Inaqovi , Opdivo , Privigen , Skyrizi y Venclyxto .

Se retiró la solicitud de autorización inicial de comercialización . Viokat (**diazóxido de colina**) se desarrolló para el tratamiento de la hiperfagia, un hambre extrema que no se puede saciar, en personas con síndrome de Prader-Willi, una afección genética que afecta el crecimiento, el desarrollo y el comportamiento.

Se retiró la solicitud para un nuevo uso de Pluvicto (lutecio (¹⁷⁷Lu) vipivotida tetraxetán), un medicamento para tratar el cáncer de próstata, para tratar a

adultos con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (CPRCm) positivo para PSMA que no presentan síntomas o tienen síntomas leves, después de que su cáncer haya empeorado a pesar del tratamiento con un medicamento bloqueador hormonal.

El CHMP ha finalizado su evaluación de una solicitud para ampliar el uso de **Opdualag (nivolumab/relatlimab)** al tratamiento del melanoma avanzado, un tipo de cáncer de piel que se ha diseminado o no puede extirparse quirúrgicamente, con niveles de PD-L1 iguales o superiores al 1 %. La PD-L1 es una proteína producida por algunas células cancerosas. Si bien la EMA no recomendó este uso, acordó que los datos pertinentes presentados con la solicitud se incluyeran en la información del producto del medicamento, para que los profesionales sanitarios tengan acceso a datos actualizados sobre los efectos de Opdualag en pacientes con melanoma avanzado con niveles de PD-L1 inferiores al 1 %.

23 Marzo 2026

El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la EMA recomendó la aprobación de cinco medicamentos en su reunión de marzo de 2026.

El comité recomendó otorgar una autorización de comercialización condicional para Adstiladrin (**nadofaragene firadenovec**) para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de vejiga no músculo-invasivo resistente al bacilo de Calmette-Guérin, con carcinoma in situ con o sin tumores papilares.

El CHMP recomendó otorgar la autorización de comercialización a Imdylltra (**tarlatamab**), un nuevo tratamiento para el cáncer de pulmón de células pequeñas en estadio avanzado y recidivante, que responde a una necesidad médica no cubierta en adultos con mal pronóstico y opciones de tratamiento limitadas. Consulte más detalles en el comunicado de prensa que aparece a continuación.

Joenia (**leniolisib**) recibió una opinión favorable para su autorización de comercialización en circunstancias excepcionales para el tratamiento del síndrome de deficiencia de fosfoinosítido 3-quinasa delta activada (APDS) en adultos y adolescentes de 12 años o más y con un peso igual o superior a 45 kg. El APDS es una enfermedad rara, hereditaria, progresiva y potencialmente mortal del sistema inmunitario. Se estima que la incidencia mundial de esta enfermedad es de 1 a 2 casos por millón de personas.

Se adoptó una opinión favorable sobre Zepzelca (**lurbinectedina**) para el tratamiento de mantenimiento en pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas en estadio avanzado cuya enfermedad no ha progresado después de la terapia de inducción de primera línea.

El CHMP recomendó otorgar una autorización de comercialización para uso pediátrico (PUMA) a Bopediat (**furosemida**) para el tratamiento del edema (hinchazón causada por exceso de líquido) de origen cardíaco o renal, edema de origen hepático e hipertensión en niños desde el nacimiento hasta los 18 años con enfermedad renal crónica. Este medicamento se presentó mediante una solicitud híbrida, que se basa en parte en los resultados de pruebas preclínicas y ensayos clínicos de un producto de referencia ya autorizado y en parte en nuevos datos.